

摘要：

礼来下一代减重药组合疗法数据亮眼，eloralintide与tirzepatide联用后，最高剂量组48周减重23.3%，高于tirzepatide单药的14.8%。不同机制联合正成为下一代减重药研发方向，礼来计划于2026年第四季度启动3期试验。数据公布后，礼来股价一度涨2.6%，随后涨幅收窄。

礼来下一代减重药组合疗法数据亮眼，显示现有减重药的减重效果仍有进一步提升空间，也意味着减重药市场的竞争正向下一代疗法延伸。

9月30日，礼来公布的2期试验数据显示，**实验性药物eloralintide与tirzepatide联用后，最高剂量组患者48周平均减重23.3%，明显高于tirzepatide单药组的14.8%**。礼来计划于2026年第四季度启动3期试验。

此次结果也表明，减重药研发正在从单一药物竞争转向不同作用机制的联合。礼来和诺和诺德均在探索这一方向，试图在现有减重药基础上进一步提高减重效果，争夺下一代肥胖症治疗市场。

数据公布后，礼来股价盘中一度上涨2.6%，随后涨幅有所收窄。



礼来公司

NYSE: LLY

1,191.46 USD

↑ 0.58% +6.83 今天

+ 关注

9月30日 GMT-4上午11:33 • 免责声明

1天

5天

1个月

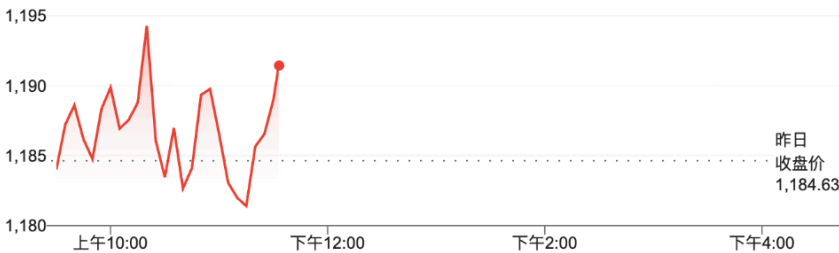
6个月

YTD

1年

5年

最大



两种药物联用，进一步放大减重效果

Eloralintide与tirzepatide作用机制不同。前者模拟人体内胰淀素（amylin）的作用，帮助抑制食欲、增强饱腹感；后者则同时作用于GLP-1和GIP两种激素通路，帮助控制血糖和体重。

礼来心脏代谢健康部门总裁Ken Custer表示，同时作用于三条激素通路，可以进一步降低食欲、改善减重效果。他将这一策略形容为“轻度激活三个激素系统”，而不是大幅强化其中任何一条通路。

此次2期试验中，15毫克tirzepatide单药组平均减重14.8%，eloralintide单药组最高减重12.3%，而最高剂量联合组平均减重23.3%，约54磅（24.5公斤）。

参与研究的德克萨斯大学西南医学中心医学教授Julio Rosenstock称这一结果“令人震撼”。

降糖效果进一步提升，但副作用仍是挑战

联合治疗不仅带来更大的减重幅度，降糖效果也有所增强。最高剂量组合组A1C平均从基线的8.1%下降2.9个百分点，高于tirzepatide单药组的2.4个百分点和eloralintide单药组的1.4个百分点。最高剂量组合组约四分之三患者达到血糖正常化。

不过，副作用仍是这一疗法需要解决的问题。最高剂量组合组中，27%的患者因副作用停药，超过五分之四的患者报告出现至少一种副作用，约半数出现恶心；tirzepatide单药组因副作用停药比例为2.9%。

Custer表示，tirzepatide早期试验中也曾出现较高的停药率，随后通过调整给药方案得到改善。礼来计划在3期试验中进一步优化剂量递增方案，以改善疗效与耐受性之间的平衡。

礼来还计划将两种药物开发为单一注射剂型，以简化患者用药。

与诺和诺德争夺下一代减重药市场

此次数据也让礼来与诺和诺德在下一代减重药领域的竞争更加受到关注。诺和诺德的CagriSema同样将作用于amylin通路的药物与Wegovy结合，希望进一步提升减重效果。

不过，不同临床试验在患者群体、试验设计、剂量和治疗周期等方面存在差异，因此两种疗法的结果不能直接横向比较。礼来也强调，不应简单比较不同试验的数据。

Leerink Partners分析师David Risinger此前表示，eloralintide可能成为礼来的“超级重磅炸弹”，并认为对于现有减重药效果不足或难以耐受副作用的患者，这一药物具有较大的潜在市场。

与此同时，eloralintide还与礼来另一款在研减重药retatrutide形成不同的研发路径。Retatrutide同样针对多种激素通路，而eloralintide则与tirzepatide组成联合疗法，为礼来下一代减重药布局提供另一条路线。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码
免费领取



限免

248

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



